



FICHA ÚNICA DE ANAMNESIS – PSICOEDUKA

Instrucciones para la familia

Estimado/a tutor/a – apoderado/a – cuidador/a:

La siguiente anamnesis tiene como objetivo recopilar información relevante sobre la historia del niño/a, su desarrollo, contexto familiar, escolar y de salud, con el fin de iniciar un proceso de evaluación e intervención integral en Psicoeduka.

Por favor, responda con la mayor sinceridad posible, considerando que no existen respuestas correctas o incorrectas, sino información necesaria para comprender su realidad.

I. DATOS DE QUIEN RESPONDE

- Nombre completo: Katherine Virginia Ibarra/ Mauricio Soto Gonzales
- Relación con el niño/a: Mamá/ Papá

Nombre del profesional que entrevista: Lady Bulla

Fecha de entrevista: 15 de abril del 2026

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NIÑO/A

- Nombre completo: Santiago Ignacio Soto Ibarra
- RUT: 26.035.314-4
- Fecha de nacimiento: 15 de diciembre del 2017
- Edad: 8 años, 4 meses y 5 días.
- Sexo: Masculino

III. MOTIVO DE CONSULTA

1. ¿Cuál es el principal motivo por el que consulta en Psicoeduka?

Los cuidadores refieren que el niño cuenta con diagnóstico previo de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), realizado hace aproximadamente dos años, a partir de evaluación por Terapia Ocupacional y posterior valoración por especialista en neurología.

Actualmente consultan con el objetivo de evaluar la pertinencia de iniciar o retomar un proceso de acompañamiento terapéutico.

Señalan como principales dificultades la presencia de altos niveles de distractibilidad, tanto en el contexto escolar como en actividades deportivas, lo que impacta en su desempeño y participación. Asimismo, refieren antecedentes familiares de TDAH en varios sobrinos

2. ¿Qué tratamientos, apoyos o intervenciones ha recibido anteriormente?

El niño ha recibido intervención en Terapia Ocupacional durante un período aproximado de tres a cuatro meses. Actualmente no se encuentra en tratamiento activo.

La madre refiere que en el último tiempo ha observado en el niño un comportamiento errático, con tendencia a la irritabilidad, distractibilidad y episodios de frustración, especialmente en situaciones que implican tolerar normas, seguir instrucciones o enfrentar actividades que no resultan de su interés.

En el contexto escolar, se reporta que en algunas ocasiones el niño finaliza las actividades antes que sus compañeros, lo que se asocia a manifestaciones de aburrimiento y posible dificultad para sostener la atención en tareas posteriores o de espera.

A nivel socioafectivo, la madre lo describe como un niño amistoso, con buena disposición al vínculo con pares.

IV. EXPECTATIVAS FAMILIARES

- ¿Cuáles son sus expectativas respecto del proceso de evaluación e intervención en Psicoeduka?

La madre manifiesta como principal expectativa que el niño pueda acceder a un proceso de evaluación e intervención personalizado, acorde a la experiencia y especialización del centro, que permita profundizar en los factores que podrían estar incidiendo en su funcionamiento actual.

Solicita una evaluación integral que considere las distintas áreas del desarrollo, incluyendo aspectos emocionales, conductuales, psicológicos y motores. En este último ámbito, refiere la presencia de conductas como manipulación constante de objetos, tendencia a apretar elementos y alta inquietud motora.

Asimismo, expresa interés en recibir orientaciones claras respecto al tipo de tratamiento más adecuado, junto con recomendaciones específicas para su manejo en los distintos contextos. Indica que el informe resultante será utilizado para gestionar una nueva evaluación con especialista en neurología.

Finalmente, la madre consulta sobre la posibilidad de incorporar, ya sea en la etapa de evaluación o en el proceso terapéutico, instancias de observación o coordinación con el establecimiento educacional y el deporte que practica, con el fin de complementar la comprensión del funcionamiento del niño en el contexto escolar.

V. ANTECEDENTES FAMILIARES

Composición familiar

- ¿Con quién vive actualmente el niño/a?
Vive con mamá, papá y hermana menor (6 años)
-

VI. ANTECEDENTES PERINATALES

Embarazo

- ¿Fue un embarazo planificado? Sí
- ¿Cómo fue la salud de la madre durante la gestación?

El embarazo fue planificado, en el contexto de una relación de pareja estable de aproximadamente ocho años, con un proyecto parental previo.

Desde el punto de vista médico, la gestación cursó con riesgo de parto prematuro, asociado a diagnóstico de cuello uterino corto, lo que implicó indicación de mayor reposo y manejo obstétrico específico, incluyendo procedimientos para favorecer la maduración pulmonar fetal. No obstante, el embarazo logró llegar a término. En términos generales, la madre refiere haber mantenido un buen estado de salud física durante la gestación.

En el ámbito emocional, señala que inicialmente el embarazo fue vivido de manera positiva; sin embargo, a lo largo de su desarrollo se presentaron diversas dificultades familiares y situaciones de estrés emocional, las cuales pudieron haber impactado su bienestar durante este periodo.

Parto

- Tipo de parto: Vaginal
-

VII. ANTECEDENTES MÉDICOS Y DE SALUD

- Diagnósticos previos: TDAH
- Medicamentos actuales (nombre y dosis): Ningun medicamento

- Alergias conocidas: Alergias tienen pendiente hacerle el test.
- Cirugías y hospitalizaciones: Tuvo un procedimiento por una caries.
- Enfermedades familiares relevantes (mentales o crónicas): Por línea materna, se reportan antecedentes de salud mental, destacando la presencia de depresión en la abuela materna, actualmente en tratamiento, así como cuadros de ansiedad en tías maternas.

Por línea paterna, no se informan antecedentes de enfermedades mentales ni condiciones crónicas relevantes.

VIII. DESARROLLO PSICOMOTOR Y FUNCIONAL

Alimentación y lactancia

- Tipo de lactancia: Mixta
- ¿Cómo fue el proceso de alimentación y destete?

Durante los primeros días posteriores al nacimiento, los cuidadores refieren haber experimentado altos niveles de estrés, asociados a dificultades en la instauración de la lactancia materna, debido a una baja producción de leche. Esta situación se acompañó de una disminución de peso inicial en el bebé, por lo que posteriormente se optó por un esquema de alimentación mixta.

Asimismo, se reportan dificultades en la regulación del sueño durante los primeros meses de vida, con patrones de descanso irregulares.

En relación con la estimulación temprana, la madre señala que, durante la primera infancia, el niño estuvo expuesto con frecuencia a contenido televisivo infantil.

Lenguaje y comunicación

- Edad inicio contacto ocular: Aproximadamente a los dos meses.
 - Edad inicio balbuceo: Antes de los seis meses.
 - Edad primera palabra: Inicio hablar aproximadamente a los nueve meses.
 -
 - ¿Interactúa con otros niños? La madre lo describe como amistoso, cuidadoso y amoroso con sus amigos.
-

Uso de pantallas

- ¿Ve pantallas? Sí

- Tipo de contenido / tiempo / supervisión: Juegos en la tablet , alrededor de una hora y media diaria con supervisión.
-

Motricidad – marcha

- Primeros pasos: Dos años
-

Sueño

- Durante los primeros meses de vida, el niño durmió junto a ambos padres. Los cuidadores refieren que en esta etapa presentaba dificultades para conciliar el sueño, requiriendo ser mecido de forma constante para lograr la regulación y el inicio del descanso.
 - En la actualidad, no se reportan dificultades significativas en el sueño. El niño logra dormir de manera autónoma, sin requerir compañía ni la implementación de rituales específicos para conciliar el sueño, manteniendo un descanso tranquilo y adecuado para su edad.
-

Control de esfínter

- El control de esfínteres se adquirió a los 2 años y 4 meses de edad. El proceso de aprendizaje se llevó a cabo mediante retiro del pañal y acompañamiento por parte de los cuidadores, logrando la adquisición del control en un período aproximado de dos semanas. Se describe como un proceso relativamente rápido y efectivo.
-

IX. ÁMBITO ESCOLAR

Jardín infantil / Sala cuna

- ¿Asistió? Sí
 - Edad de ingreso: Seis meses
 - Motivo de ingreso: Trabajo de la madre.
 - Adaptación y relación con pares: Proceso tranquilo , se mostraba participativo.
-

Escolaridad actual

- Nombre del establecimiento: Colegio Aleman
- Nivel / curso: Tercero básico

Trayectoria escolar

- Establecimientos anteriores y motivo de cambio:

Misma institución durante sus años escolares.

- ¿Repitencias? No
 - Apoyos o intervenciones previas (PIE, tutorías, etc.): No
-

- Relación con docentes: La madre la describe como una relación afectuosa y cercana, basada en el respeto.
 - Relación con pares: Es un niño amoroso, cuidadoso y amistoso con sus pares.
 - Desempeño académico general: La madre lo describe como óptimo y con buenas notas.
-

XI. REGULACIÓN, INTERESES Y OBSERVACIONES

- Otras observaciones relevantes: Al indagar respecto a posibles cambios en el entorno que pudieran estar incidiendo en el comportamiento del niño, la madre refiere que estos podrían asociarse a un aumento en las demandas tanto escolares como deportivas. Señala que el niño practica fútbol en un contexto competitivo, no como actividad extracurricular, destacando que el rendimiento deportivo tiene para la familia un nivel de prioridad equivalente al ámbito académico.

Asimismo, menciona que, durante el presente año escolar, se realizó una reorganización de los cursos, implicando la integración de nuevos compañeros, lo que podría constituir un factor de ajuste en su contexto social.

En el ámbito familiar, la madre reporta conductas disruptivas en la interacción con su hermana, describiendo episodios en los que el niño presenta conductas de tipo impulsivo, como tomarle las manos y doblarle los dedos

Muchísimas gracias!